研究方案 • 公共卫生博士

在初级卫生保健中组织对复杂且并存的社会需求的跨部门应对

与所照护的不同患者类型相适应的网络配置



Eric Bernier, LL.M.、M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
公共卫生博士 · 卫生系统、组织与政策 · ESPUM，蒙特利尔大学

共同导师：
Nadia Sourial 博士与 Géraldine Layani 博士

01 背景

加拿大初级卫生保健中，每 2 名患者就有 1 人报告一项社会需求 · *Kosowan et al., 2025*

19 %
的魁北克家庭在 2023 年面临食物不安全（2018 年为 14%）
ISQ, 2026

40 %
的家庭将一半收入用于住房：住房与吃饭只能二选一
ISQ, 2026

需要区分的三个概念
并存用来计数；复杂性用来描述；跨部门应对在一个辖区内组织。

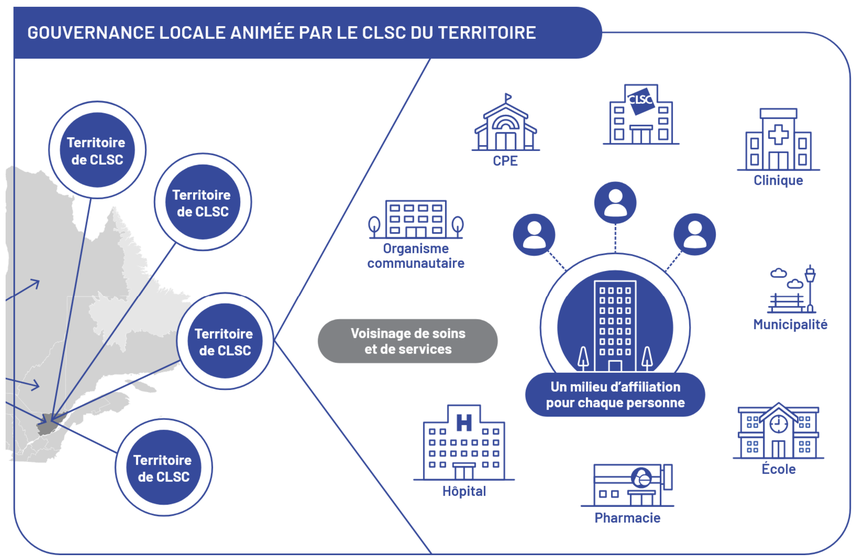
纳入标准
并存
同时存在至少两项社会需求。
Kreuter et al., 2021

加以描述，不作要求
复杂性
慢性病、残障、心理健康问题与社会脆弱性的累积。
Kuluski et al., 2017

在辖区内组织
跨部门应对
卫生以外的其他部门与卫生部门一起、针对健康或其决定因素采取的行动：CLSC、医院、GMF、药房、社区组织、市政府、学校、CPE、私营部门。
MSSS, 2017; Leppo et al., 2013

一线服务政策 • MSSS, 2026

CLSC 辖区成为参照单位



CLSC 的四个角色

- 导航者
- 协调者
- 跨部门引领者
- 共同推动者

"秉持共享治理的精神" · MSSS, 2026, p. 42 · 示意图：MSSS, 2026

虚构案例 • 贯穿主线

MP Protocole 女士 · 58 岁
谁来回应？与谁一起？谁来协调？

驱逐通知 · 食物不安全 · 债务 · 抑郁症（临床背景）

空白所在

CLSC 必须负责协调。 但面对某一需求组合，没有任何依据说明应动员哪些合作伙伴、如何联系他们、由谁协调。 **人们了解服务规划，却不了解围绕就医路径实际形成的网络。**

研究问题

对于在初级卫生保健中接受照护、具有复杂且并存的社会需求的不同类型患者，跨部门应对是如何组织的？

目标：将每种类型对应到…
需求 类型 → 合作伙伴 配置 → 及其 协调者

02 方法

研究现场：Lanaudière 地区 3 个差异鲜明的 CLSC 辖区（物质剥夺程度因 MRC 而异，从 7% 到 50%），跨部门合作的先行地区（设有跨部门圆桌会议） · 多阶段设计 · O2：解释性序贯混合 SNA，从 CLSC 出发展开

哪些类型？
O1 • 识别
范围综述
4 至 6 个情境案例，由 6 至 8 位相关人员验证
已发表研究 → 反复出现的类型 → 情境案例
→ 类型转化为情境案例
MP *她的类型在研究中被识别*

谁动员谁？
O2 • 分析
从 CLSC 出发绘图
3 个 CLSC，再到它们提名的联系人
MP 情境案例 潜在网络 · 过去 12 个月 真实网络
→ 潜在网络与真实网络
MP *她成为一个情境案例*

为何及如何？
O2 • 分析
定性 SNA
15–25 次访谈 • 每种类型 2 至 3 条真实就医路径
"你们为什么合作、如何合作？"
→ 对互动的解释
MP *她的真实就医路径得到解释*

建议什么？
O3 • 建议
审议式工作坊
15–20 名参与者，包括患者伙伴
患者伙伴 · 初级卫生保健 · 社区 · 地方治理 · 市政、私营
→ 各类型的建议
MP *她的个案在工作坊中审议*

整合
32 个月 • 2026 → 2029
按类型的联合展示表

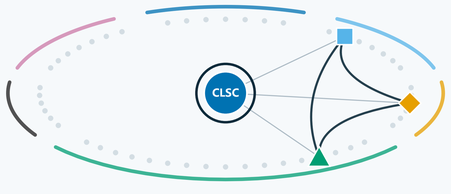
类型	网络	原因	建议
A			
B			
C			

MP *为她的类型提供参考指引*

03 预期结果

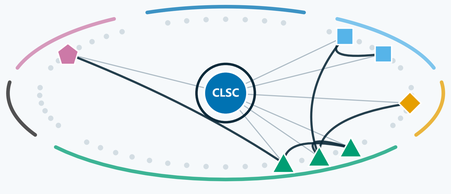
虚构示例 · **在每个 CLSC，自我中心网络随类型而变**

A 以住房为主
驱逐通知



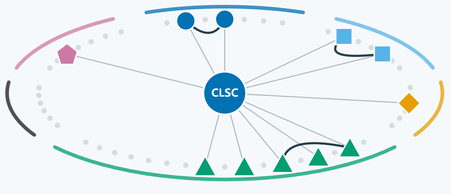
3 个合作伙伴，全部相连 • CLSC 协调

B Protocole 女士
住房 · 食物 · 债务



7 个合作伙伴，仍彼此相连 • CLSC 协调

C 叠加 + 抑郁症
需求相同，另加抑郁症



11 个合作伙伴，联系很少 • 无协调者

CLSC（自我） · 卫生与社会服务 · 指定协调者 · 一线服务、药房 · 由合作伙伴申报的联系 · 社区 · 未被动员的机构 · 市政 · 教育、幼儿 · 就业、司法、私营

- H1 部门：随类型而变 → *部门构成*
- H2 共同的核心，各自的外围 → *共同合作伙伴*
- H3 合作伙伴越多，联系越少 → *规模与密度*
- H4 CLSC 是否导航并协调？ → *指定协调者*
- H5 性别是否改变应对方式？ → *女性版、男性版*
- ≠ 真实与潜在：差距多大？ → *情境案例 vs 12 个月*

04 影响与成果

不是普适的"理想网络"： 而是为每种类型提供参考指引。

对个人
与其需求组合相匹配的应对

对 CLSC 及其合作伙伴
参考指引：动员谁、如何联系、谁来协调

对一线服务政策
基线状态；围绕 CLSC 四个角色的建议

对研究
类型–网络假设；潜在网络与真实网络的差距

传播： 向 3 个辖区反馈 · 研究方案已发布 (OSF) · 论文

所有版本 · FR · EN · ES · 中文 · العربية · ᐊᓄᓕᒃ · Innu · 色盲友好 · 低视力 · Aa 易读版 · 音频
您的想法 · 评论 · 阅读 · 联系
我的经历 · erjb-web.github.io

参考文献：CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell 与 Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017; 2026, 一线照护与服务政策 · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016 · Colour-blind version: Okabe-Ito colours and one shape per sector